

ÍNDICE

1. OBJETO	3
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN	3
2.1 Alcance	3
2.2 Distribución	3
3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y REFERENCIAS	3
3.1 Definiciones y abreviaturas	3
3.2 Referencias	4
4. DESARROLLO	5
4.1 Generalidades	5
4.2 Responsabilidades	5
4.2.1 Servicio de Medicina Laboral	5
4.2.2 Departamento de Seguridad e Higiene	6
4.2.3 Departamento de Recursos Humanos	6
4.2.4 Comisión Interdisciplinaria de Seguimiento	6
4.3 Consentimiento Informado y Acta de Compromiso	6
4.3.1 Consentimiento Informado	6
4.3.2 Acta de compromiso de Hábitos Saludables	7
4.4 Procedimiento de Control de IMC	7
4.4.1 Protocolo de Medición	7
4.4.3 Frecuencia de los Controles	8
4.5 Medidas Organizativas Preventivas	8
4.5.1 Readecuación Preventiva de Tareas	8
4.5.2 Suspensión Transitoria de Asignación a Tareas Críticas	8
4.5.3 Suspensión de horas extras, reemplazos y guardias	9
4.6 Restricciones Operativas del DSyHL	9
4.7 Garantías del Trabajador ante Medidas Organizativas	9
4.8 Tratamiento Médico y Nutricional	9
4.8.1. Prescripción del Tratamiento	9
4.8.2. Obligaciones del Trabajador	10
4.8.3. Obligaciones de la Cooperativa	10

Elaborado: (sector)	Revisado: (sector)	Aprobado: (sector)
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

4.8.4. Evaluación de Progreso	10
4.9 Régimen ante incumplimientos.....	10
4.9.1. Principios Rectores	11
4.9.2. Incumplimientos Sancionables	11
4.9.3 Escala Progresiva de Medidas	11
4.10 Procedimiento Disciplinario	11
4.11 Protección de datos y confidencialidad	12
4.12 Garantías antidiscriminatorias	12
4.13 Prevención y promoción de hábitos saludables	12
4.14 Disposiciones complementarias	12
5. REGISTROS.....	13
6. INDICADORES	13
7. ANEXOS.....	13

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 3 de 18

1. OBJETO

Establecer el marco normativo interno integral para la implementación de un programa de prevención, control, seguimiento y tratamiento de la obesidad y el sobrepeso de los trabajadores de la Cooperativa Copelco Ltda. (en adelante, “la Cooperativa” o “COPELCO”), en ejercicio del deber de seguridad que le compete al empleador conforme al artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (en adelante, “LCT”), la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, su Decreto Reglamentario N° 351/79 y concordantes, y la Resolución SRT N° 905/2015 sobre exámenes médicos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

2.1 Alcance

El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para todo el personal en relación de dependencia de COPELCO Ltda., sin distinción de categoría, antigüedad, jerarquía o modalidad contractual, incluyendo personal de planta permanente, contratados a plazo fijo, personal eventual y trabajadores en período de prueba.

Asimismo, se aplicará al personal de empresas contratistas y subcontratistas que desarrollen tareas dentro del ámbito de la Cooperativa, en la medida que su condición física incida en la seguridad operativa, conforme al artículo 30 de la LCT. A tal efecto, COPELCO incluirá en los contratos con terceros, cláusulas que obliguen al cumplimiento de las disposiciones del presente procedimiento.

2.2 Distribución

Personal propio y Contratado.

3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y REFERENCIAS

3.1 Definiciones y abreviaturas

Obesidad y Sobrepeso: Acumulación anormal o excesiva de grasa corporal perjudicial para la salud. Se considera sobrepeso un IMC igual o superior a 25 kg/m² y obesidad un IMC igual o superior a 30 kg/m².

IMC (Índice de Masa Corporal): Indicador biométrico que resulta de dividir el peso corporal en kilogramos por el cuadrado de la estatura en metros (kg/m²). Parámetro estándar aceptado por la OMS.

Medicina Laboral: Servicio médico de la Cooperativa, a cargo de profesionales habilitados, responsable de controles de salud, determinación del IMC y evaluación de aptitud psicofísica.

DSyHL: Departamento de Seguridad e Higiene Laboral, conforme a la Ley 19.587 y Dto. 351/79.

Tareas Críticas: Aquellas que implican exigencias físicas relevantes, trabajo en altura, espacios confinados, conducción de vehículos, manipulación de instalaciones eléctricas, herramientas pesadas o maquinarias, turnos de guardia u otras actividades que requieran aptitud psicofísica plena.

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 4 de 18

Tratamiento Indicado: Plan terapéutico integral prescripto al trabajador cuyo IMC se encuentre fuera de los parámetros saludables.

Consentimiento Informado: Declaración escrita del trabajador mediante la cual presta conformidad al procedimiento, previa información clara, veraz y suficiente.

Comisión Interdisciplinaria: Comité de seguimiento del programa con carácter consultivo y preventivo, sin facultades disciplinarias ni acceso a información médica sensible.

3.2 Referencias

Artículo 75 LCT: Deber de seguridad del empleador, quien debe adoptar las medidas necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores.

Artículos 62 y 63 LCT: Principio de buena fe que obliga a ambas partes a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador.

Artículos 64 y 65 LCT: Facultades de organización y dirección del empleador, ejercidas con carácter funcional y atendiendo a los fines de la empresa.

Artículo 66 LCT: Ius variandi – facultad del empleador de modificar las formas y modalidades del trabajo, sin alterar modalidades esenciales del contrato ni causar perjuicio material o moral al trabajador.

Artículos 84 y 86 LCT: Deber de diligencia del trabajador y obligación de someterse a los controles médicos que disponga el empleador.

Ley 19.587 (arts. 4, 5, 8 y 9): Normas de higiene y seguridad que obligan al empleador a examinar las condiciones de salud de los trabajadores y a adoptar medidas preventivas.

Decreto 351/79 (Cap. 3, arts. 9 a 12): Servicios de medicina del trabajo y exámenes de salud.

Resolución SRT 905/2015: Régimen de exámenes médicos en salud.

Ley 26.396: Declara de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios, incluyendo obesidad.

Resolución 1420/2022 del Ministerio de Salud de la Nación: Ampliación de prestaciones del PMO para tratamientos vinculados a trastornos alimentarios y obesidad.

Ley 26.529: Derechos del Paciente – Derecho a la intimidad, confidencialidad y consentimiento informado.

Ley 25.326: Protección de Datos Personales – Los datos de salud son datos sensibles.

Ley 23.592: Ley Antidiscriminación.

Ley 23.660 (arts. 15 y 16): Ley de Obras Sociales.

Ley 24.557 y modificatorias: Ley de Riesgos del Trabajo.

Ley 18.284 y Dto. 2126/1971: Código Alimentario Argentino.

Resolución 732/2016: Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad.

Convenio 111 de la OIT: Sobre discriminación en materia de empleo y ocupación.

Recomendaciones de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud.

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 5 de 18

4. DESARROLLO

4.1 Generalidades

El procedimiento se orienta a prevenir, informar y concientizar sobre el reconocimiento de la obesidad como enfermedad y factor de riesgo laboral, promoviendo gestiones y medidas internas que garanticen una mejor calidad de vida y salud psicofísica de todos los trabajadores, facultando a COPELCO Ltda. a adoptar medidas organizativas preventivas, incluyendo:

- Readequación preventiva de tareas: Reasignación temporal del trabajador a funciones compatibles con su condición psicofísica, cuando la evaluación médico-laboral determine que las tareas habituales implican riesgo para su salud o la seguridad operativa.
- Suspensión transitoria de asignación a tareas críticas: Restricción temporal de la asignación a tareas que impliquen trabajo en altura, espacios confinados, conducción de vehículos, manipulación de instalaciones eléctricas, herramientas pesadas o maquinarias, u otras actividades de riesgo, hasta tanto se determine la aptitud psicofísica del trabajador.
- Suspensión de horas extras, reemplazos y guardias: Restricción temporal de la asignación de horas extraordinarias, funciones de reemplazo y turnos de guardia cuando la condición de salud del trabajador así lo aconseje según dictamen de Medicina Laboral.

El presente procedimiento se implementa con estricto respeto al principio de no discriminación, igualdad de trato y dignidad del trabajador, garantizando que ninguna medida será adoptada con carácter punitivo ni implicará trato desigual arbitrario.

4.2 Responsabilidades

4.2.1 Servicio de Medicina Laboral

El Servicio de Medicina Laboral tiene a su cargo:

1. Realizar los controles periódicos de IMC (peso, talla, cálculo del índice) conforme al cronograma del punto 4.4.3 del presente procedimiento.
2. Confeccionar la Historia Clínica Laboral de cada trabajador, con carácter estrictamente confidencial.
3. Efectuar el seguimiento y evaluación de la evolución del trabajador bajo tratamiento.
4. Emitir los certificados de aptitud psicofísica y las recomendaciones de readecuación, suspensión de tareas críticas o restricción de horas extras/guardias/reemplazos.
5. Comunicar al DSyHL y a Recursos Humanos únicamente las conclusiones sobre aptitud laboral (apto, apto con restricciones, no apto), sin revelar diagnósticos ni datos clínicos, conforme a la Ley 25.326.
6. Derivar al trabajador a profesionales externos cuando la complejidad del caso lo requiera.
7. Registrar en la matriz de riesgos del puesto de trabajo la aptitud psicofísica requerida para el correcto desempeño de las funciones.

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 6 de 18

4.2.2 Departamento de Seguridad e Higiene

1. Elaborar y mantener actualizada la Matriz de riesgos por Puesto de Trabajo.
2. Evaluar la compatibilidad entre la condición física del trabajador y los requerimientos de seguridad del puesto.
3. Determinar restricciones operativas y medidas de seguridad complementarias.
4. Proponer la readecuación de tareas o la suspensión de asignación a tareas críticas.
5. Evaluar la asignación de elementos de protección personal (EPP) especiales.
6. Participar en la investigación de incidentes o accidentes laborales en los que la condición física pudiera haber sido factor contribuyente.

4.2.3 Departamento de Recursos Humanos

1. Gestionar las notificaciones fehacientes al trabajador.
2. Instrumentar las medidas organizativas y, en su caso, disciplinarias que correspondan.
3. Ejecutar la suspensión de horas extras, reemplazos y guardias.
4. Resguardar la documentación del procedimiento en el legajo personal.
5. Coordinar con el asesor legal la viabilidad jurídica de cada medida antes de su aplicación.

4.2.4 Comisión Interdisciplinaria de Seguimiento

COPELCO podrá conformar una Comisión Interdisciplinaria integrada por un representante de Medicina Laboral (quien la presidirá), un representante del DSyHL, un representante de Recursos Humanos, el gerente y/o supervisor del área involucrada. Dicha comisión tendrá carácter consultivo y preventivo, sin facultades disciplinarias ni de acceso a información médica sensible, la cual quedará exclusivamente en poder de Medicina Laboral.

Funciones: supervisar la correcta implementación del procedimiento; evaluar mensualmente los resultados del programa; proponer modificaciones; intervenir como instancia consultiva previa a medidas organizativas; elevar informe anual a la Presidencia de la Cooperativa, con indicadores de gestión.

4.3 Consentimiento Informado y Acta de Compromiso

4.3.1 Consentimiento Informado

Previo al inicio de cualquier control, el trabajador suscribe el formulario de Consentimiento Informado (Anexo I), mediante el cual se le informa de manera clara y accesible: el objeto y alcance del programa; los estudios y mediciones a realizar; el carácter confidencial de los datos de salud (Ley 25.326); los derechos del trabajador (acceso, rectificación, supresión de datos; derecho a segunda opinión médica); las obligaciones derivadas de los arts. 62, 63, 84 y 86 de la LCT; las consecuencias del incumplimiento del tratamiento indicado; y las medidas organizativas que la Cooperativa se encuentra facultada a adoptar.

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 7 de 18

La negativa a suscribir el consentimiento no exime al trabajador de la obligación de someterse a los controles médicos periódicos (art. 86 LCT; Res. SRT 905/2015). En tal caso, se labrará acta ante testigos dejando constancia de la negativa y de la información brindada.

4.3.2 Acta de compromiso de Hábitos Saludables

Cada trabajador suscribe un Acta de Compromiso de Hábitos Saludables (Anexo II), mediante la cual manifiesta su compromiso de adoptar y sostener conductas responsables en materia de alimentación, actividad física y cuidado integral de la salud, en el marco del deber de buena fe y colaboración previsto en la LCT.

4.4 Procedimiento de Control de IMC

4.4.1 Protocolo de Medición

Los controles de IMC se realizan exclusivamente por personal médico o de enfermería habilitado del Servicio de Medicina Laboral, conforme al siguiente protocolo:

- Peso corporal: Medido con balanza clínica calibrada (certificación INTI vigente), con el trabajador descalzo y con ropa liviana. Valor en kilogramos con un decimal.
- Talla: Medida con tallímetro homologado, trabajador descalzo, en posición erecta. Valor en metros con dos decimales.
- Cálculo del IMC: Fórmula $IMC = \text{peso (kg)} / \text{talla}^2 \text{ (m}^2\text{)}$.
- Circunferencia de cintura: Dato complementario para evaluación de riesgo cardiovascular.

Los controles se llevan a cabo bajo la dirección de personal de Medicina Laboral, resguardándose la confidencialidad de los resultados y dando cumplimiento al protocolo técnico correspondiente.

4.4.2 Clasificación, Niveles de Riesgo y Acción

CLASIFICACIÓN	IMC (kg/m ²)	RIESGO	ACCIÓN
Bajo peso	< 18.5	Moderado	Derivación nutricional
Peso normal	18.5 - 24.9	Bajo	Control periódico
Sobrepeso	25.0 - 29.9	Elevado	Plan nutricional obligatorio. Evaluación de restricciones.
Obesidad Grado I	30.0 - 34.9	Alto	Tratamiento médico + nutricional. Readecuación preventiva de tareas. Evaluación de suspensión de tareas críticas.
Obesidad Grado II	35.0 - 39.9	Muy alto	Tratamiento integral obligatorio. Readecuación preventiva. Suspensión de tareas críticas. Suspensión de hs. extras/reemplazos/guardias.
Obesidad Grado III	≥ 40.0	Crítico	Protocolo especial + aptitud psicofísica integral. Suspensión de tareas críticas. Suspensión de hs. extras/reemplazos/guardias. Evaluación de reubicación.

4.4.3 Frecuencia de los Controles

CLASIFICACIÓN IMC	FRECUENCIA DE CONTROL	EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA
Bajo peso / Normal	Anual (examen periódico)	Laboratorio básico
Sobrepeso (25-29.9)	Semestral	Laboratorio + perfil lipídico y glucémico
Obesidad I (30-34.9)	Trimestral	Lab. completo + evaluación cardiovascular
Obesidad II-III (≥ 35)	Mensual (6 meses), luego bimestral	Evaluación integral + aptitud psicofísica para el puesto

Medicina Laboral podrá aumentar la frecuencia de controles cuando existan factores de riesgo agravantes o cuando el puesto implique riesgos específicos que lo justifiquen.

4.5 Medidas Organizativas Preventivas

Cuando, a través de los controles de seguimiento realizados por Medicina Laboral, se detecten valores de peso o IMC que superen los parámetros médicos recomendados y que pudieran incidir en la aptitud para el desempeño seguro de las tareas, el trabajador será notificado en forma fehaciente y confidencial. A partir de dicha notificación, COPELCO Ltda. queda facultada para adoptar, de manera fundada, razonable y proporcionada, las siguientes medidas organizativas preventivas:

4.5.1 Readecuación Preventiva de Tareas

En ejercicio de las facultades de organización y dirección (arts. 64, 65 y 66 LCT), y en cumplimiento del deber de seguridad (art. 75 LCT), COPELCO podrá disponer la readecuación preventiva de las tareas del trabajador cuando Medicina Laboral, previa evaluación, determine que las funciones habituales implican riesgo para su salud o la seguridad operativa en razón de la obesidad verificada. La readecuación se instrumentará mediante notificación fehaciente al trabajador, indicando las nuevas tareas asignadas, su carácter temporal y la fundamentación médico-laboral. La readecuación será revisada en cada control periódico y cesará cuando Medicina Laboral certifique la recuperación de la aptitud psicofísica para las tareas originales.

4.5.2 Suspensión Transitoria de Asignación a Tareas Críticas

Cuando la evaluación conjunta de Medicina Laboral y el DSyHL determine que la condición de peso del trabajador compromete la seguridad en el desempeño de tareas críticas —entendidas como aquellas que implican trabajo en altura, espacios confinados, conducción de vehículos, manipulación de instalaciones eléctricas, herramientas pesadas o maquinarias, u otras actividades que requieran aptitud psicofísica plena—, COPELCO podrá disponer la suspensión transitoria de dicha asignación hasta tanto se determine la aptitud del trabajador.

Esta medida se funda en el deber de prevención (art. 75 LCT) y en las obligaciones de la Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79, y tiene como único objeto evitar riesgos ciertos y actuales para la seguridad del trabajador y de terceros.

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 9 de 18

La suspensión de asignación a tareas críticas no importará suspensión de la relación laboral, manteniéndose el trabajador en funciones compatibles con su condición.

4.5.3 Suspensión de horas extras, reemplazos y guardias

COPELCO podrá disponer, por dictamen de Medicina Laboral, la restricción temporal de la asignación de horas extraordinarias, funciones de reemplazo y turnos de guardia al trabajador cuyo estado de salud, en razón de la obesidad verificada, así lo aconseje.

Dicha restricción se funda en la obligación del empleador de preservar la salud e integridad psicofísica del trabajador (art. 75 LCT), evitando la exposición a cargas horarias y esfuerzos adicionales que pudieran agravar la condición de salud o incrementar el riesgo de accidentes.

La medida será revisada periódicamente conforme a la evolución del trabajador y cesará cuando Medicina Laboral determine la aptitud para retomar dichas funciones.

4.6 Restricciones Operativas del DSyHL

El DSyHL, en coordinación con Medicina Laboral, elaborará y mantendrá actualizada la Matriz de Requerimientos Psicofísicos por Puesto de Trabajo. Cuando se informe que un trabajador presenta un IMC que pudiera comprometer la seguridad en su puesto, el DSyHL realizará: evaluación de riesgo específica del puesto; verificación de disponibilidad de EPP adecuados; análisis de restricciones operativas temporarias; propuesta de medidas correctivas o reubicación; y emisión de informe técnico fundado.

Las restricciones operativas tendrán carácter temporal y serán revisadas en cada control periódico.

4.7 Garantías del Trabajador ante Medidas Organizativas

Todas las medidas previstas en el presente capítulo:

- Serán adoptadas exclusivamente por razones objetivas de seguridad y salud laboral, debidamente fundadas en dictamen de Medicina Laboral y/o informe técnico del DSyHL.
- No implicarán reducción ni menoscabo de la categoría profesional del trabajador.
- Serán de carácter temporal y revisables periódicamente.
- Serán notificadas en forma fehaciente al trabajador, con indicación de los fundamentos, alcance y carácter temporal.
- No tendrán carácter sancionatorio ni discriminatorio (Ley 23.592).
- El trabajador podrá solicitar la revisión de la medida y, en caso de disconformidad, ejercer los derechos previstos en el art. 66 LCT.

4.8 Tratamiento Médico y Nutricional

4.8.1. Prescripción del Tratamiento

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 10 de 18

Cuando el resultado del control de IMC determine la necesidad de tratamiento, Medicina Laboral lo hará saber al trabajador para que éste recurra a un profesional externo competente en la materia, quien elaborará un Plan de Tratamiento Individualizado que contemplará, según la gravedad: plan nutricional personalizado; tratamiento médico con derivación a especialistas; acompañamiento psicológico; y programa de actividad física adaptada.

El trabajador deberá gestionar el inicio y continuidad de este tratamiento mediante su cobertura médico-asistencial, conforme a la Resolución 1420/2022 del Ministerio de Salud de la Nación.

4.8.2. Obligaciones del Trabajador

El trabajador, conforme a los deberes de buena fe, colaboración, diligencia y observancia de las medidas de seguridad (arts. 62, 63, 84 y concordantes de la LCT), deberá:

1. Asistir puntualmente a todos los controles médicos programados.
2. Cumplir con el plan nutricional y/o médico prescripto.
3. Asistir a las consultas con especialistas externos cuando fuera derivado.
4. Presentar comprobantes de asistencia a consultas externas y resultados de estudios dentro de los 5 (cinco) días hábiles de realizados.
5. Comunicar de inmediato cualquier cambio en su estado de salud que pueda incidir en su aptitud laboral.
6. No abandonar el tratamiento sin autorización de Medicina Laboral.

4.8.3. Obligaciones de la Cooperativa

1. Facilitar al trabajador el tiempo necesario para controles médicos por parte de Medicina Laboral, dentro del horario laboral, sin descuento salarial.
2. Garantizar la confidencialidad absoluta de los datos médicos (Ley 25.326 y Ley 26.529).
3. Proveer opciones saludables en servicios de alimentación, cuando los hubiere.
4. No utilizar la información del programa con fines discriminatorios (Ley 23.592).
5. Garantizar el derecho a segunda opinión médica (art. 2° inc. e, Ley 26.529).
6. Asumir los costos de controles realizados por Medicina Laboral.

4.8.4. Evaluación de Progreso

Se considerará cumplimiento satisfactorio cuando se verifique: reducción progresiva del IMC conforme a objetivos; mejora comprobable en indicadores complementarios de salud; o asistencia regular con evidencia de adherencia al tratamiento.

No constituye incumplimiento sancionable la falta de resultados en la reducción de peso cuando exista adherencia comprobada al tratamiento. La sanción recae sobre la conducta (incumplimiento de obligaciones), no sobre el resultado (peso corporal).

4.9 Régimen ante incumplimientos

4.9.1. Principios Rectores

Las medidas disciplinarias se rigen por: proporcionalidad (art. 67 LCT); gradualidad progresiva; contemporaneidad; non bis in ídem; derecho de defensa (descargo escrito dentro de los 3 días hábiles de dispuesta la medida); y no discriminación (las medidas se fundan en el incumplimiento de obligaciones laborales, nunca en la condición física).

4.9.2. Incumplimientos Sancionables

1. Inasistencia injustificada a los controles médicos programados.
2. Abandono del tratamiento prescripto sin autorización médica.
3. Falta de presentación de comprobantes de asistencia a consultas y estudios.
4. Negativa injustificada a someterse a exámenes médicos periódicos (art. 86 LCT).
5. Falsificación o adulteración de documentación médica.

4.9.3 Escala Progresiva de Medidas

ETAPA	INCUMPLIMIENTO	MEDIDA LABORAL	FUNDAMENTO
1ª	Primera inasistencia injustificada o primera evidencia de abandono del tratamiento	Apercibimiento escrito con intimación a retomar el tratamiento en 5 días hábiles	Arts. 62, 63 y 67 LCT
2ª	Segunda inasistencia o incumplimiento reiterado	Suspensión de 1 a 5 días según gravedad, con notificación fehaciente	Arts. 67, 218, 219, 220 LCT
3ª	Tercer incumplimiento o negativa sistemática al tratamiento indicado	Suspensión de 5 a 15 días y reevaluación de aptitud psicofísica para el puesto	Arts. 67, 218-220 LCT; Art. 9 Ley 19.587
4ª	Incumplimiento grave y reiterado tras agotar instancias previas, con riesgo comprobado	Procedimiento de desvinculación con justa causa	Arts. 242, 243, 75 LCT; Ley 19.587

4.10 Procedimiento Disciplinario

Cada medida cumplirá el siguiente trámite:

- 1) Documentación: Medicina Laboral emite informe detallando el incumplimiento.
- 2) Evaluación jurídica: RRHH remite al asesor legal para evaluar procedencia y proporcionalidad.
- 3) Notificación fehaciente al trabajador de la medida disciplinaria adoptada y posibilidad de descargo.
- 4) Descargo: 3 días hábiles para presentar defensa escrita y prueba.
- 5) Impugnación: 30 días corridos conforme art. 67, segundo párrafo, LCT.

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 12 de 18

4.11 Protección de datos y confidencialidad

Los datos de salud obtenidos son datos sensibles (art. 2°, Ley 25.326). En consecuencia: solo tendrán acceso a datos clínicos los profesionales de Medicina Laboral; el DSyHL y RRHH solo recibirán información de aptitud laboral (apto / apto con restricciones / no apto) sin diagnósticos ni valores de IMC; los datos se almacenarán en sistemas con acceso restringido; se prohíbe la difusión de datos individuales de salud.

El trabajador tendrá derecho a acceder a su Historia Clínica Laboral, solicitar rectificación o supresión de datos y obtener copia de la documentación médica obrante en su legajo.

4.12 Garantías antidiscriminatorias

COPELCO garantiza que el presente programa se implementará con estricto apego a la normativa antidiscriminatoria vigente (Ley 23.592; Convenio 111 OIT; art. 17 LCT). Ningún trabajador podrá ser despedido, suspendido, trasladado o perjudicado en su carrera profesional por su condición de sobrepeso u obesidad en sí misma. Las medidas organizativas y disciplinarias se fundan exclusivamente en el incumplimiento de obligaciones laborales o en razones objetivas de seguridad, nunca en la condición física del trabajador.

Todo trabajador que considere haber sido objeto de un acto discriminatorio podrá formular denuncia ante la representación sindical o ante los organismos administrativos y judiciales competentes.

4.13 Prevención y promoción de hábitos saludables

COPELCO implementará acciones de sensibilización, información y capacitación destinadas a promover hábitos saludables.

Asimismo, la Cooperativa podrá implementar: campañas de concientización sobre nutrición y salud; talleres y charlas con profesionales; convenios con gimnasios o centros de actividad física; mejora de la oferta alimentaria en establecimientos de la Cooperativa; e incentivos no económicos para trabajadores que alcancen objetivos de salud.

4.14 Disposiciones complementarias

1. Revisión del Procedimiento

El presente procedimiento será revisado con periodicidad anual por la Comisión Interdisciplinaria, o antes si mediaran cambios en la normativa aplicable.

2. Vigencia

El presente procedimiento entrará en vigencia a los 10 (diez) días corridos de su notificación a la totalidad del personal (a través de los canales virtuales utilizados al efecto para las comunicaciones institucionales, por ej. Canal de WhatsApp, página web, entre otros), plazo durante el cual se realizarán las acciones de difusión y capacitación correspondientes.

3. Notificación y Difusión

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 13 de 18

COPELCO notificará el presente procedimiento a cada trabajador de manera individual y fehaciente, requiriendo firma de acuse de recibo (Anexo V). El procedimiento también podrá ser exhibido en los lugares de trabajo conforme al art. 4° inc. c) de la Ley 19.587.

5. REGISTROS

ANEXO I – CONSENTIMIENTO INFORMADO, documento en formato papel, se archiva en legajo personal de cada operario ubicada en oficina de RR.HH.

ANEXO II – ACTA DE COMPROMISO DE HáBITOS SALUDABLES documento en formato papel, se archiva en legajo personal de cada operario ubicada en oficina de RR.HH.

ANEXO III – PLAN DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO documento en formato papel, se archiva en legajo personal de cada operario ubicada en oficina de Medicina Laboral.

ANEXO IV – ACTA DE CONSTATAción DE NEGATIVA documento en formato papel, se archiva en legajo personal de cada operario ubicada en oficina de RR.HH.

ANEXO V – ACUSE DE RECIBO Y NOTIFICACIÓN documento en formato papel, se archiva en legajo personal de cada operario ubicada en oficina de RR.HH.

RPG 15-01 Frecuencia de Controles de Peso, documento en formato digital, se archiva en carpeta de Medicina Laboral.

6. INDICADORES

- Cumplimiento de controles programados
Fórmula: $(\text{N}^\circ \text{ de controles realizados} / \text{N}^\circ \text{ de controles programados}) \times 100$
- Adherencia al tratamiento indicado
Fórmula: $(\text{N}^\circ \text{ de trabajadores con evidencia de adherencia} / \text{N}^\circ \text{ de trabajadores con tratamiento prescripto}) \times 100$
- Evolución favorable del IMC
Fórmula: $(\text{N}^\circ \text{ de trabajadores con reducción progresiva del IMC} / \text{N}^\circ \text{ total de trabajadores en seguimiento}) \times 100$
- Cumplimiento de presentación de constancias médicas externas
Fórmula: $(\text{N}^\circ \text{ de constancias presentadas en término} / \text{N}^\circ \text{ de constancias requeridas}) \times 100$
- Casos con restricciones operativas activas
Fórmula: $(\text{N}^\circ \text{ de trabajadores con restricciones} / \text{N}^\circ \text{ total de trabajadores evaluados}) \times 100$

7. ANEXOS

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 14 de 18

ANEXO I – CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _____, DNI N° _____, legajo N° _____, en mi carácter de trabajador/a de la Cooperativa Copelco Ltda., por el presente DECLARO:

1. Que he sido informado/a de manera clara, completa y comprensible sobre el Programa de Prevención, Control, Seguimiento y Tratamiento de la Obesidad y el Sobrepeso implementado por la Cooperativa.
2. Que conozco el objeto, alcance, metodología y finalidad del programa.
3. Que se me ha informado sobre mis derechos, incluyendo el acceso a mi historia clínica, la confidencialidad de mis datos de salud y el derecho a una segunda opinión médica.
4. Que conozco las obligaciones que asumo conforme a los arts. 62, 63, 84 y 86 de la LCT.
5. Que se me ha informado sobre las consecuencias del incumplimiento del tratamiento que pudiera ser prescripto.
6. Que se me ha informado sobre las medidas organizativas preventivas que la Cooperativa se encuentra facultada a adoptar (readecuación de tareas, suspensión de tareas críticas, suspensión de horas extras/reemplazos/guardias).
7. Que presto mi consentimiento libre, informado y voluntario para la realización de los controles médicos y el tratamiento de mis datos de salud conforme a la Ley 25.326.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

Aclaración: _____

Firma del profesional médico: _____ M.P. N°: _____

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 15 de 18

ANEXO II – ACTA DE COMPROMISO DE HáBITOS SALUDABLES

En la ciudad de _____, a los ____ días del mes de _____ del año _____, el/la Sr./Sra. _____, DNI N° _____, empleado/a de la Cooperativa Copelco Ltda., manifiesta haber tomado conocimiento del Procedimiento de Prevención y Concientización sobre Obesidad y Sobrepeso vigente en la Institución, del presente Procedimiento Integral y de las medidas organizativas preventivas que la Cooperativa se encuentra facultada a adoptar.

En tal sentido, declara comprender que la obesidad y el sobrepeso constituyen factores de riesgo para la salud psicofísica y pueden impactar en el desempeño seguro de las tareas laborales, especialmente en aquellas que implican riesgo operativo.

En el marco del deber de buena fe, colaboración y cuidado previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, el/la trabajador/a asume los siguientes compromisos:

1. Adoptar y sostener hábitos de vida saludables, incluyendo una alimentación equilibrada, actividad física adecuada y controles médicos periódicos.
2. Colaborar con las acciones preventivas impulsadas por la Cooperativa, participando en instancias de información, capacitación y controles médicos laborales.
3. En caso de que los controles realizados por Medicina Laboral indiquen valores de peso o IMC superiores a los recomendados médicamente, iniciar y sostener el tratamiento correspondiente a través de su cobertura médica personal, conforme a la Resolución 1420/2022 del Ministerio de Salud de la Nación.
4. Acreditar, cuando le sea requerido, la realización de consultas médicas y/o nutricionales mediante presentación de constancias de asistencia, resguardándose la confidencialidad del diagnóstico y tratamiento.
5. Aceptar y cumplir con las medidas organizativas preventivas que la Cooperativa disponga en ejercicio de sus facultades legales (readecuación de tareas, suspensión de tareas críticas, suspensión de horas extras/reemplazos/guardias), en el entendimiento de que las mismas tienen carácter estrictamente preventivo y no sancionatorio.

Se deja expresa constancia de que la información médica será tratada con estricta confidencialidad conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales y secreto médico.

El incumplimiento injustificado y reiterado del presente compromiso, cuando implique riesgo laboral objetivo, podrá dar lugar a la adopción de medidas organizativas o disciplinarias conforme a la legislación vigente y el presente Procedimiento Integral.

La presente acta se firma en prueba de conformidad, compromiso y toma de conocimiento.

Firma del/de la trabajador/a: _____

Aclaración: _____

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 16 de 18

ANEXO III – PLAN DE TRATAMIENTO PRESCRIPTO

(Formulario para completar por el profesional tratante particular del trabajador)

Trabajador/a: _____ Legajo: _____

Fecha de evaluación: _____ IMC actual: _____ Clasificación: _____

Peso actual: _____ kg Talla: _____ m Circ. cintura: _____ cm

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: _____

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO:

Objetivo a 3 meses: _____

Objetivo a 6 meses: _____

Objetivo a 12 meses: _____

PLAN PRESCRIPTO:

☐ Plan nutricional ☐ Tratamiento médico ☐ Acompañamiento psicológico ☐ Actividad física

DETALLE:

MEDIDAS ORGANIZATIVAS RECOMENDADAS:

☐ Readecuación preventiva de tareas ☐ Suspensión de tareas críticas ☐ Suspensión de hs. extras/reemplazos/guardias

FRECUENCIA DE CONTROLES: _____ PRÓXIMO CONTROL: _____

Firma del profesional: _____ M.P. N°: _____

Firma del trabajador/a: _____ Fecha: _____

	PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 17 de 18

ANEXO IV – ACTA DE CONSTATACIÓN DE NEGATIVA

En la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ de 20____, siendo las _____ horas, en las instalaciones de la Cooperativa Copelco Ltda., se deja constancia de que el/la trabajador/a _____, DNI N° _____, legajo N° _____, fue citado/a a presentarse ante el Servicio de Medicina Laboral para la realización del control de IMC previsto en el Procedimiento Interno vigente. Que, debidamente notificado/a de la obligación de someterse a dicho control conforme al art. 86 de la LCT y a la Resolución SRT N° 905/2015, el/la trabajador/a:

- ☐ Se negó a realizarse el control.
- ☐ No se presentó a la citación sin justificación.
- ☐ Se negó a firmar el Consentimiento Informado.

Que se le informó de las consecuencias legales y laborales de su negativa.

Testigo: _____ DNI: _____ Firma: _____

Firma del profesional médico: _____ M.P. N°: _____

Firma del representante de RRHH: _____

	PREVENCION DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES PG 15	Revisión: 00
		Fecha de vig.: 12/03/2026
		Página N°: 18 de 18

ANEXO V – ACUSE DE RECIBO Y NOTIFICACIÓN

Yo, _____, DNI N° _____, legajo N° _____, dejo constancia de que en el día de la fecha he recibido copia íntegra del Programa/Procedimiento de “PREVENCION DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS TRABAJADORES” (PG 15) de la Cooperativa Copelco Ltda., comprendiéndose su contenido y alcance.

Asimismo, he sido informado/a de que el incumplimiento de las obligaciones allí establecidas podrá dar lugar a la adopción de medidas organizativas preventivas y, en su caso, disciplinarias conforme a la normativa laboral vigente y al Procedimiento Integral.

Lugar y fecha: _____

Firma del trabajador/a: _____ Aclaración: _____